

守護安全與尊嚴的界線： 保護性約束技術稽核指南

單元 14 | 標準化流程與 10 大關鍵指標解析



將法規標準化為全人照護旅程



題號 01 | 為何約束？尋找安全的平衡點

能正確說明約束的目的。



意識混亂



跌倒危險



行為無法配合

約束是預防更大傷害的最後防線，當病人出現上述情形時方可啟動。

題號 04 & 05 | 授權的黃金鐵三角



照服員不可獨立決定或執行約束，必須在護理人員指導下完成。

題號 06 | 緊急狀況的時效生命線

0 小時 | 緊急啟動

1 小時內 | 時效緊迫

24 小時內 | 法規完備

0

1

24

情況緊急者，為保護病人生命安全立即執行。

必須取得醫師「口頭」或「書面」醫囑。

必須取得病人或家屬的「同意書」。

稽核口訣：先保護，一小時醫囑，一天內同意。

題號 02 & 03 | 接觸前的雙重安全門



Gate 1：感染控制

能正確執行前、後洗手。

保護病人，也保護自己



雙重確認完畢，
授權進入執行區。



Gate 2：身分確認

能正確執行病人辨識。

確認對象正確，杜絕醫療錯誤

題號 07 | 約束環境與設備的安全雷達

能正確執行約束環境與設備的檢查。

1

床欄是否穩固拉起？

4

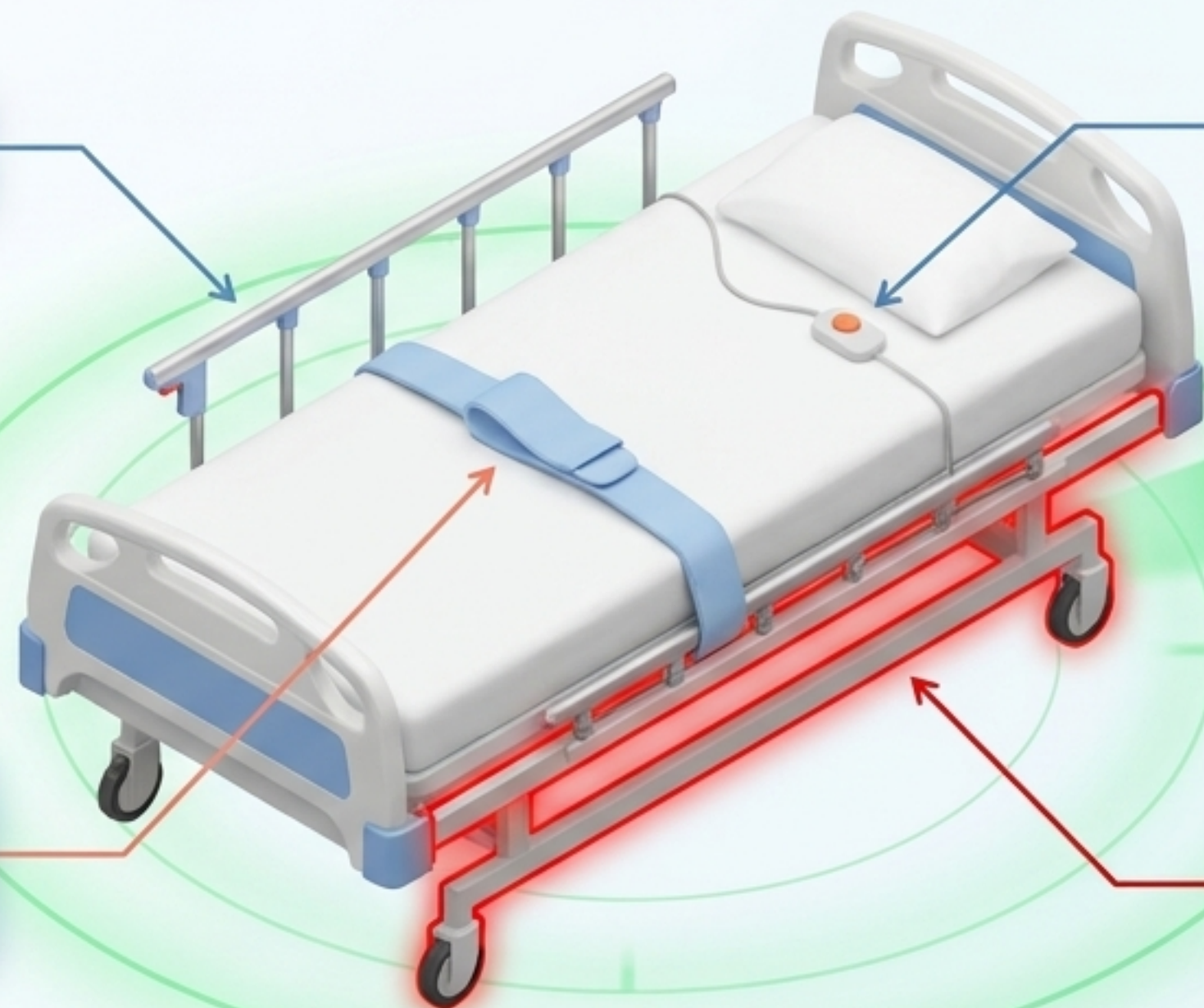
呼叫鈴是否在病人可輕易觸及的範圍內？

2

約束用物是否有破損？
尺寸是否合適？

3

致命錯誤區：綁帶必須固定於「穩固的床架」上，絕對不可固定於「可活動的床欄」！

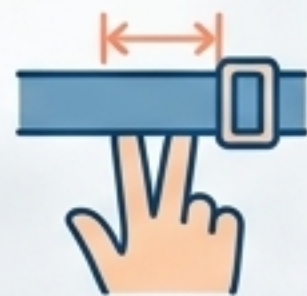


題號 08 | 動態監測的黃金頻率

能正確說出每 30 分鐘~1 小時需密切觀察約束病人並記錄。



情緒反應與躁動程度



約束帶鬆緊度
(維持一至兩指寬的緩衝空間)

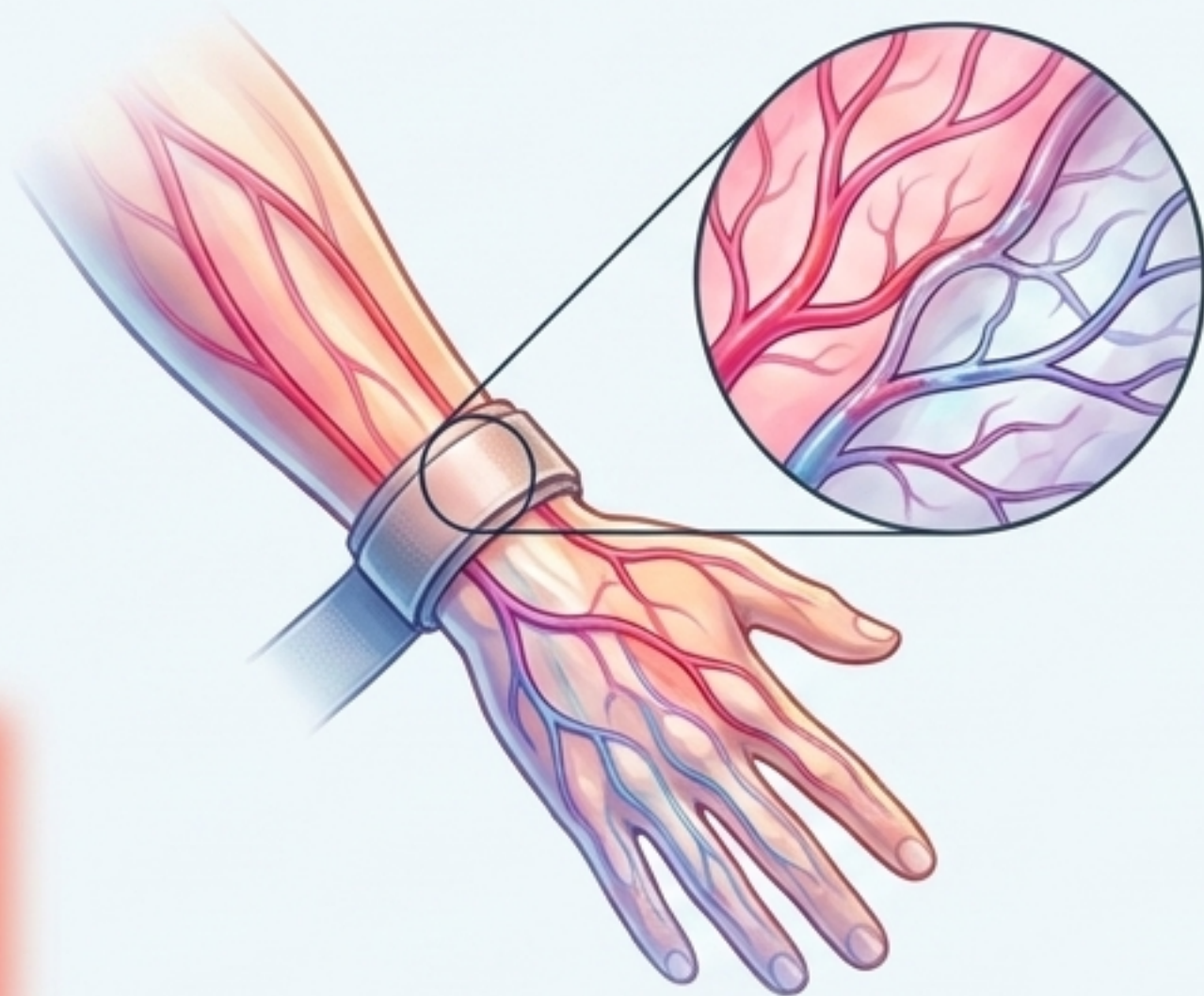


姿勢是否舒適、有無壓迫

約束啟動的那一刻，才是照護挑戰的開始。

題號 09 | 末梢血循異常警報系統

審誰標準：評估病人約束部位血循，發現有異常時(或無人陪伴時)必須即時向護理人員報告，並列入交班。



The 4 P's of Circulation

顏色：蒼白或發紫？



溫度：冰冷？



感覺：麻木或刺痛？



脈搏：末梢脈搏微弱？



發現異常 / 無人陪伴 → 立即報告護理人員 → 確實列入交班紀錄！

題號 10 | 捍衛基本需求的尊嚴照護

能正確協助病人飲水、進食、如廁等生活照護。



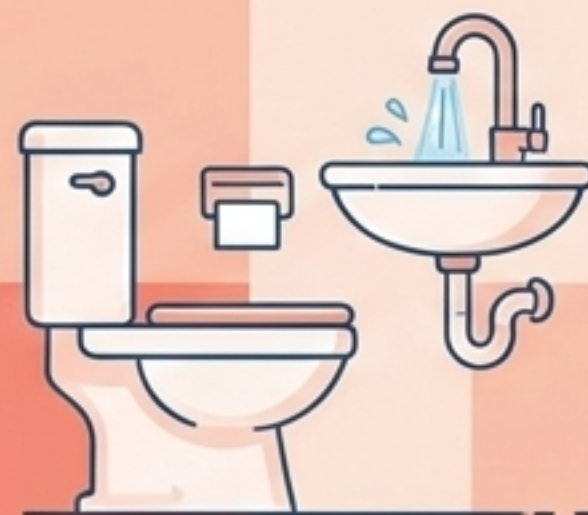
飲水

定時主動提供水分，滋潤乾涸的唇舌。



進食

安全餵食，評估吞嚥狀況，避免噎咳風險。



如廁

維持會陰部清潔與自尊，避免因約束導致失禁的挫折。

失去行動自由的時刻，我們就是他們感知世界與維持生命尊嚴的雙手。

單元 14 | 保護性約束 10 大稽核指標總表

【決策與授權】	【安全與執行】	【監測與生活】
01. 目的：意識混亂、跌倒、無法配合	02. 感染控制：前後洗手	08. 觀察頻率：每 30 分鐘～1 小時紀錄
04. 條件：醫囑 + 護理指導	03. 安全辨識：病人辨識	09. 血循評估：異常 / 無人陪伴即時報告交班
05. 要件：必要性+ 同意書簽名	07. 環境確認：設備與環境檢查	10. 基本尊嚴：飲水、進食、如廁照護
06. 緊急：1hr 醫囑 / 24hr 同意書		



守護，從不只是一張檢核表

保護性約束，是不得已的防護，而不是照護的終點。

每一次的精準檢查、每一小時的細心紀錄，都是我們對生命尊嚴最堅定的守護。